

CAPÍTULO 14.19

Síndrome de Sjögren

PERFIL EUNACOM 1.05.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome de Sjögren** (pronunciado frecuentemente como "Chogren" en español) es una enfermedad autoinmune sistémica crónica caracterizada principalmente por la infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas, lo que conduce a una disminución de las secreciones.

Aunque su sello distintivo es la sequedad, es una patología que puede afectar múltiples órganos, por lo que su reconocimiento clínico detallado es fundamental para el examen EUNACOM.

Clínica: El Síndrome de Sicca (Sequedad)

La manifestación más frecuente, y en ocasiones la única, es el **Síndrome de Sicca** o síndrome de sequedad. Los pacientes presentan una tríada clásica de compromiso glandular:

- **Xeroftalmia (Sequedad Ocular):**
- *Los pacientes describen sensación de "arena en los ojos" o molestias oculares inespecíficas.*
- Clínicamente puede manifestarse como una **queratitis punctata** (lesiones en la córnea por falta de lubricación).
- *Existe una hipolacrimia marcada.*
- **Xerostomía (Sequedad de Boca):**
- Disminución de la producción de saliva.
- *Sensación de que "el pan se queda pegado" al tragar.*
- Dificultad para hablar de forma prolongada sin beber agua.
- **Otras sequedades:**
- **Sequedad vaginal:** *Causa frecuente de dispareunia (dolor al tener relaciones sexuales).*
- Sequedad de piel y de vías respiratorias.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología del Sjögren se basa en una **epitelitis autoinmune**. Los linfocitos T y B infiltran las glándulas salivales y lagrimales, destruyendo progresivamente el tejido acinar y reemplazándolo por fibrosis, lo que anula la capacidad de secreción.

Manifestaciones Extraglandulares

En casos de síndrome de Sjögren más severo, la enfermedad deja de limitarse a las glándulas y afecta a otros sistemas. Estas manifestaciones suelen definir el pronóstico del paciente:

- **Artritis:** Es la manifestación extraglandular más frecuente. Se presenta como una poliartritis de pequeñas articulaciones, similar a la **Artritis Reumatoide**, pero con una característica clave: suele ser **no erosiva**.
- **Compromiso Pulmonar:** Puede evolucionar a una **fibrosis pulmonar** (enfermedad pulmonar intersticial difusa).
- **Compromiso Renal:** La manifestación típica es la **nefritis intersticial**, que puede llevar a acidosis tubular renal.
- **Vasculitis:** Manifestada frecuentemente como púrpura palpable.
- **Riesgo de Linfoma:** Los pacientes con Sjögren tienen un riesgo significativamente mayor (hasta 40 veces más) de desarrollar Linfoma no Hodgkin (especialmente de tipo MALT).

Diagnóstico y Marcadores

El diagnóstico se basa en la combinación de clínica, pruebas de función glandular, serología y, en casos de duda, histología.

Anticuerpos y Laboratorio

Los marcadores serológicos son fundamentales y suelen preguntarse con frecuencia:

TABLA 14.19.1: MARCADOR VS FRECUENCIA / RELEVANCIA

MARCADOR	FRECUENCIA / RELEVANCIA
Anticuerpos Anti-Ro (SSA)	Muy específicos y frecuentes.
Anticuerpos Anti-La (SSB)	Muy específicos, suelen ir de la mano con el Anti-Ro.
Factor Reumatoide (FR)	Positivo en un porcentaje muy alto de pacientes (incluso sin tener AR).
ANA (Anticuerpos Antinucleares)	Habitualmente positivos con patrón moteado.
Hipergammapatemia	Es común encontrar una elevación policlonal de las gammaglobulinas.

Biopsia Salival

Cuando los anticuerpos son negativos o el cuadro es atípico, se recurre a la biopsia de **glándulas salivales menores**. - Se toma una muestra de la mucosa oral (labio inferior). - Es preferible sobre la biopsia de parótida por ser más sencilla y tener menos complicaciones. - Se busca un "score de foco" (cúmulos de linfocitos).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que el perfil típico de un Sjögren es: **Mujer + Ojo seco/Boca seca + ANA (+) + Factor Reumatoide (+) + Anti-Ro/Anti-La (+).**

Clasificación: Primario vs. Secundario

- **Sjögren Primario:** Ocurre de forma aislada, sin otra enfermedad autoinmune asociada.
- **Sjögren Secundario:** Se presenta en el contexto de otra patología sistémica. Las asociaciones más comunes son:
- **Artritis Reumatoide** (la más frecuente).
- **Lupus Eritematoso Sistémico.**
- **Esclerosis Sistémica.**

En el caso del Sjögren secundario, el manejo debe incluir obligatoriamente el tratamiento de la enfermedad de base.

Tratamiento

El enfoque terapéutico se divide según la gravedad de los síntomas.

1. Manejo Sintomático (Síndrome de Sicca)

Es el pilar del tratamiento para la mayoría de los pacientes: -

Xeroftalmia: Uso de **lágrimas artificiales** de forma recurrente. - **Xerostomía:** Hidratación constante (pequeños sorbos de agua). * Uso de **secretagogos:** Sustancias que estimulan la salivación (como gotas de limón o chicles sin azúcar). En casos severos, pilocarpina. - **Sequedad Vaginal:** Lubricantes vaginales a base de agua.

2. Manejo Sistémico (Manifestaciones Extraglandulares)

Cuando hay compromiso de órganos internos o artritis, el manejo se asemeja al del **Lupus Eritematoso Sistémico:** -

Hidroxicloroquina: Ha demostrado gran utilidad para el manejo de la fatiga y los dolores articulares. - **Corticoides:** Se utilizan para exacerbaciones sistémicas o compromiso de órganos nobles (pulmón, riñón). - **Inmunosupresores (ahorradores de corticoides):** Como Metotrexato o Azatioprina, según el órgano afectado.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El uso de secretagogos como la pilocarpina está contraindicado en pacientes con asma no controlada o glaucoma de ángulo estrecho debido a sus efectos colinérgicos.

Perlas EUNACOM

- **Ojo con el RN:** Las madres con Sjögren (o Lupus) que tienen **Anti-Ro positivo** tienen riesgo de que su hijo nazca con **Bloqueo Cardíaco Congénito** (Lupus Neonatal).
- **Linfoma:** Si un paciente con Sjögren presenta un aumento brusco de volumen parotídeo unilateral o desaparición del Factor Reumatoide/Hipocomplementemia, sospechar transformación a Linfoma.
- **Diagnóstico Diferencial:** No toda sequedad es Sjögren. Considerar fármacos (antidepresivos, antihistamínicos), edad avanzada o radioterapia previa.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente con sequedad ocular, sequedad bucal y artritis no erosiva. ANA positivo con anti-Ro y anti-La positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome de Sjögren. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Síndrome de sicca (sequedad): xeroftalmía, xerostomía y sequedad vaginal; manifestación más frecuente del Sjögren
- Manifestaciones extraglandulares: artritis no erosiva (la más importante), fibrosis pulmonar, nefritis intersticial
- Marcadores: factor reumatoide positivo + ANA positivo con anti-Ro y anti-La positivos
- Biopsia de mucosa oral (glándulas salivales menores) apoya el diagnóstico
- Tratamiento de sicca: lágrimas artificiales, hidratación oral/secretagogos, lubricación vaginal
- Manifestaciones extraglandulares: manejo similar al lupus (corticoides + hidroxiclороquina)
- Sjögren secundario: asociado a lupus o artritis reumatoide, manejar además la enfermedad de base

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME DE SJÖGREN)**PREGUNTA 1**

Paciente con sequedad ocular, sequedad bucal y artritis no erosiva. ANA positivo con anti-Ro y anti-La positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Lupus eritematoso sistémico
- B)** Artritis reumatoide
- C)** Síndrome de Sjögren
- D)** Esclerodermia
- E)** Enfermedad mixta del tejido conectivo

PREGUNTA 2

¿Cuál es el manejo más adecuado para la xeroftalmía en un paciente con síndrome de Sjögren?

- A)** Corticoides tópicos
- B)** Lágrimas artificiales
- C)** Hidroxiclороquina
- D)** Ciclofosfamida
- E)** Rituximab

PREGUNTA 3

¿Qué tejido se biopsia para apoyar el diagnóstico de síndrome de Sjögren?

- A)** Parótida
- B)** Glándula submandibular
- C)** Mucosa oral (glándulas salivales menores)
- D)** Conjuntiva ocular
- E)** Ganglio cervical

RESUMEN: SÍNDROME DE SJÖGREN

El síndrome de Sjögren se manifiesta principalmente con un síndrome de sicca (sequedad), que es su manifestación más frecuente y a veces la única. Incluye xeroftalmía (sequedad ocular con queratitis puntata, disminución de la lágrima), xerostomía (sequedad bucal) y sequedad de otros órganos como sequedad vaginal. En casos severos puede presentar manifestaciones extraglandulares: artritis no erosiva (la más importante), fibrosis pulmonar y nefritis intersticial. El diagnóstico se basa en criterios que incluyen la clínica, anticuerpos y eventualmente biopsia salival (mucosa oral para glándulas salivales menores). Los marcadores son: factor reumatoide positivo (alto porcentaje), ANA positivo con perfil anti-Ro y anti-La positivos. El tratamiento del síndrome de sicca es sintomático: lágrimas artificiales para la xeroftalmía, mayor ingesta de agua o secretagogos para la xerostomía, y lubricación vaginal. Para las manifestaciones extraglandulares se maneja similar al lupus con corticoides, ahorradores de corticoides e hidroxiclороquina. Existe el Sjögren primario y el secundario (a lupus, artritis reumatoide, etc.).